

(表 1)³⁾。SLB により病理所見が得られた場合には呼吸器科医、放射線科医、病理医による「多分野の専門家による集学的検討」(multi-disciplinary discussion: MDD)を行い、IPF の診断を行うことが推奨されている²⁾。IPF の診断が不確実な場合、その後の治療反応や経過で再度 MDD を行い、診断を見直すことも重要とされている。

日本では IPF は特発性間質性肺炎の一病型として、厚生労働省の指定難病に挙げられており、難病指定医が作成した臨床調査個人票のデータに基づき、規定の基準を満たしていれば居住の自治体で認定される。指定難病患者は重症度Ⅲ以上、もしくは軽症であっても高額な医療を継続することが必要であれば、医療費の公費補助が受けられる(表 2)。

ii) IPF 急性増悪の診断

2016 年に国際的なワーキンググループから報告されている IPF 急性増悪の診断フローチャートを図 2 に示す。誘因がある急性増悪と誘因がない特発性急性増悪に分類される⁴⁾。

b 問診と身体所見

IPF と類似する過敏性肺炎や全身性疾患に伴う肺病変を鑑別するために、職業歴や生活環境、服用薬剤、家族歴、既往歴、合併症などの詳細な問診が必要である。労作時呼吸困難の出現時期と推移を把握することは、診断に必要であり、その後の治療方針や予後予測のためにも重要である。理学所見では、パチ指や聴診での捻髪音に加えて、サルコイドーシスや膠原病を意識した肺外の身体所見にも留意する。

c 画像所見

胸部 X 線写真ではびまん性網状陰影が両側中下肺野、末梢側優位に広がり、しばしば肺の容積減少を伴う(図 3a)。過去に検診や医療機関で撮られた画像を取り寄せて経時的变化を知ることは、病態進行の把握に有用である。HRCT は IPF の診断において必要不可欠である。典型例では胸膜下肺底部優位に分布す

る蜂巣肺を認める(図 3b)。IPF 以外の疾患を示唆するような所見とされるいわゆる alternative diagnosis パターンにみられる所見(嚢胞、モザイクパターン、すりガラス陰影優位、粒状陰影、上中肺優位の分布、胸膜プラークの存在など)がないことも IPF 診断には重要な情報になる。

d 血液検査所見

間質性肺炎の血清マーカーとして KL-6、SP-D、SP-A は高率に陽性となり、病態のモニタリング、治療反応の評価に有用とされているが、これらのマーカーは、単独で診断の確定根拠や病勢の指標にできるほどのものではない。その他には、非特異的であるが、乳酸脱水素酵素(LDH)も高値となりやすい。自己抗体では抗核抗体やリウマチ因子が IPF 症例の 10~20% に認められるが、高い抗体価(>1:160)は膠原病の存在を疑う。CEA や CYFRA, CA19-9, SLX といった腫瘍マーカーも、間質性肺炎だけでも高値になることがあるが、悪性腫瘍の合併に注意する。

e 呼吸機能検査と血液ガス検査

一般的に IPF では拘束性換気障害が認められる。肺拡散能低下はより早期から認められる。近年、IPF を対象とした臨床試験では、疾患進行の指標として努力性肺活量(FVC)の変化が用いられることが多い。た

表 2 特発性間質性肺炎の重症度分類判定表

重症度分類	安静時動脈血ガス	6 分間歩行時 SpO ₂
I	80 Torr 以上	90%未満の場合はⅢにする
Ⅱ	70 Torr 以上 80 Torr 未満	90%未満の場合はⅢにする
Ⅲ	60 Torr 以上 70 Torr 未満	90%未満の場合はⅣにする (危険な場合は測定不要)
Ⅳ	60 Torr 未満	測定不要

Ⅲ以上は医療費助成あり

[難病情報センター Web サイト、特発性間質性肺炎(指定難病 85)より引用 (<https://www.nanbyou.or.jp/entry/302>)]

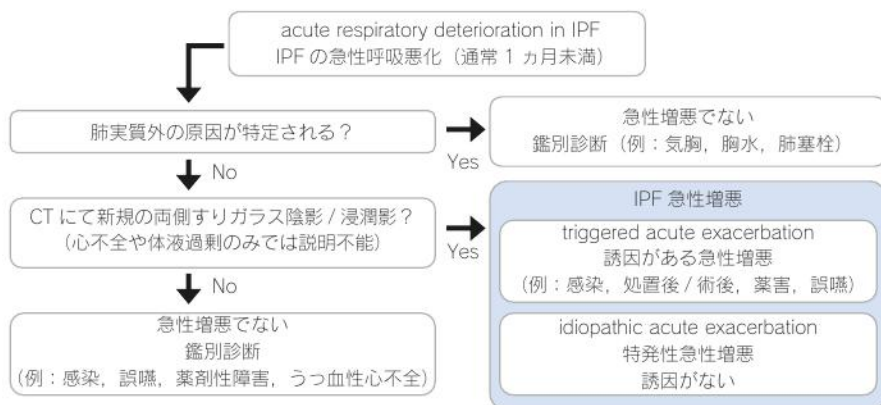


図 2 IPF 急性増悪の診断フローチャート

[Collard HR, et al: Am J Respir Crit Care Med 194: 265, 2016 より作成]